

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS ONCOLÓGICOS

Validación de alcance con contraparte

Una síntesis para confirmar que comprendimos correctamente el problema, los procesos, las responsabilidades y el resultado esperado antes de continuar el desarrollo.

Propósito de esta reunión

Revisar las propuestas, registrar ajustes y acordar las decisiones necesarias para construir un producto operativo y verificable.

31 DE JULIO DE 2026

Documento para revisión clínica, operativa y administrativa. No contiene datos de pacientes ni reemplaza protocolos oficiales.

Lo que entendimos

La prioridad no es automatizar decisiones clínicas. Es construir una fuente de verdad operacional, actualizada y gobernada.

Situación actual

- Información distribuida entre PDF, Word, correos y notas.
- Dificultad para confirmar vigencia, estado y responsables.
- Slots, pretests y tareas dependen de coordinación manual.
- Los reportes no comparten todavía definiciones aprobadas.

Resultado del MVP

- Inventario consultable y actualizado.
- Protocolos, cohortes y criterios versionados.
- Gestión trazable de slots, pretesting y tareas.
- Reportes con fecha de corte y definiciones visibles.

Qué podrá hacer un usuario autorizado

- Buscar estudios por patología, línea, biomarcador, centro y estado.
- Ver qué versión de protocolo está vigente, quién la confirmó y cuándo.
- Distinguir reclutamiento, seguimiento, hold, cierre y archivo.
- Gestionar oportunidades operativas sin emitir elegibilidad.
- Reconstruir cambios relevantes mediante auditoría.

Principio no negociable

La plataforma apoya la organización y la preselección administrativa. La elegibilidad final corresponde siempre al investigador principal y al equipo del estudio.

Un ciclo de vida compartido

Proponemos separar el estado operativo del estudio de la disponibilidad de cupos o slots.

Preactivación Próximo a abrir; permite anticipar oportunidades.	Activo reclutando Abierto y buscando participantes.	Activo en seguimiento No recluta; mantiene participantes en control.
Hold Reclutamiento detenido temporalmente.	Cerrado Sin actividad operacional vigente.	Archivado Disponible únicamente para historia y trazabilidad.

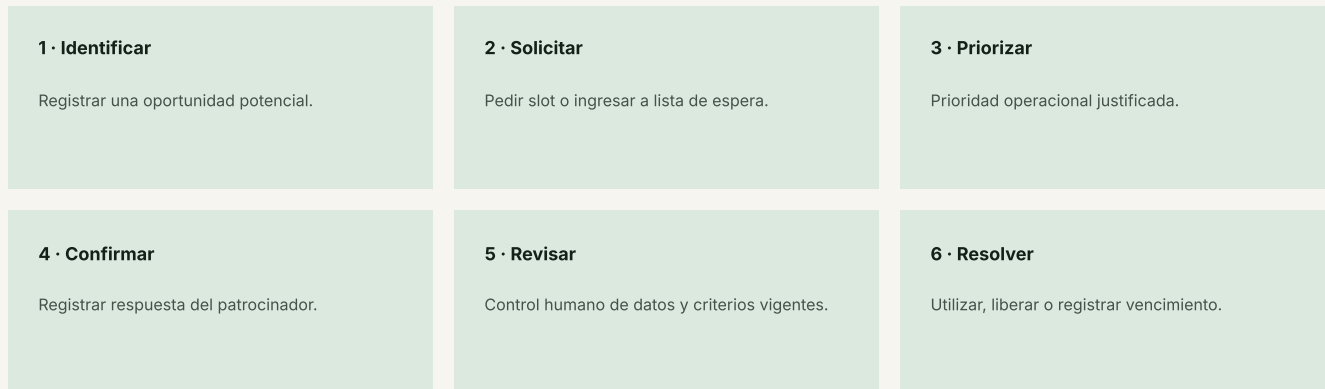
Información mínima propuesta

- Código, nombre y título oficial.
- Patrocinador, fase y diseño.
- Patología, escenario y línea.
- Cohortes, ramas y biomarcadores.
- Centro e investigador responsable.
- Coordinadora responsable.
- Estado operativo y disponibilidad.
- Versión vigente del protocolo.
- Fecha, fuente y responsable de verificación.
- Próxima fecha de revisión.

Necesitamos confirmar

Quién mantiene cada estudio, quién reemplaza a esa persona, cada cuánto se revisa la información y cuándo debe mostrarse como desactualizada.

Flujo propuesto para slots



La lista de espera no constituye un ranking clínico. Todo movimiento debe conservar fecha, fuente, responsable y motivo.

Seguimiento propuesto para pretesting



Usuarios y responsabilidad

- Investigador principal.
- Médico investigador u oncólogo derivador.
- Enfermera coordinadora.
- Jefatura de enfermería.
- Coordinación administrativa.
- Factibilidad y preactivación.
- Administración técnica.
- Auditor autorizado.

Los permisos se definirán por centro, estudio, acción y relación con el recurso. Participar en una reunión o poseer un cargo no concede automáticamente acceso clínico.

Antes de utilizar datos reales

- Aprobar datos mínimos y fundamento o consentimiento aplicable.
- Definir permisos de visualización y modificación.
- Separar información identificatoria, clínica y operativa.
- Definir retención, eliminación y custodia documental.
- Aprobar descargas, exportaciones, auditoría y respuesta ante incidentes.

Fuera del MVP administrativo

Elegibilidad automática, extracción automática de protocolos y recomendaciones clínicas.

Audio en comités, integración con ficha clínica y mensajería externa.

Entorno inicial

Hasta que exista aprobación institucional, el desarrollo, las pruebas y las demostraciones utilizarán únicamente datos ficticios.

Decisiones solicitadas

TEMA	PROPUESTA	VALIDACIÓN
Estados	Preactivación, reclutamiento, seguimiento, hold, cerrado y archivado.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Inventario	Coordinadora responsable, supervisión y fecha de próxima revisión.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Slots	Solicitud, espera, asignación, uso, liberación y vencimiento.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Pretesting	Tareas administrativas con fechas, vigencia y responsables.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Pacientes	Solo datos ficticios hasta aprobar privacidad y permisos.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Elegibilidad	Siempre corresponde al investigador y al equipo clínico.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
IA y voz	Fuera del MVP administrativo inicial.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Reportes	Implementar después de aprobar definiciones de KPI.	☐ Aprobar ☐ Ajustar

Acuerdos y observaciones

Por CICUC

Nombre:

Cargo:

Firma y fecha:

Por el equipo del proyecto

Nombre:

Cargo:

Firma y fecha: